

Surveillance épidémiologique des infections invasives à pneumocoques (IPD)

2025

Auteurs : C. Dambre¹

Révision: L. Cornelissen¹ • L. Cuypers² • S. Desmet² • H. Theeten³ • P Carrillo⁴

¹Epidémiologie des maladies infectieuses, Sciensano; ²Centre national de référence pour les infections invasives à *Streptococcus pneumoniae*, UZ Leuven; ³Departement Zorg; ⁴Fédération Wallonie-Bruxelles

Messages clés

2479 cas d'IPD en 2025 – à nouveau un nombre record

En 2025, 2479 infections invasives à pneumocoques ont été rapportées en Belgique par le CNR, le nombre le plus élevé depuis le début de la surveillance. C'est une augmentation de 17% par rapport à 2024 (n=2120).

Augmentation la plus marquée chez les personnes âgées

L'incidence des IPD a augmenté dans les différents groupes d'âge mais la plus forte est observée chez les personnes de 85 ans et plus (+36% par rapport à 2024). L'incidence reste la plus élevée chez les enfants de moins de 2 ans et chez les plus de 85 ans.

Sérotype 12F le sérotype le plus fréquent en 2025

En 2025, le sérotype 12F était le sérotype le plus fréquent dans tous les groupes d'âge et était responsable d'un cinquième de tous les cas. Une augmentation du sérotype 12F avait déjà été observée l'année dernière et elle s'est encore poursuivie.

Nouveaux changements dans les sérotypes chez les enfants

Grâce à une couverture vaccinale élevée, les sérotypes inclus dans le vaccin PCV13 ont fortement diminué chez les jeunes enfants. En 2025, seulement 6% de toutes les infections étaient encore causées par les types PCV13. Parallèlement, 50% étaient causés par des sérotypes PCV20 supplémentaires.

La vaccination chez les adultes reste trop peu utilisée

Chez les adultes, plus de 70% des cas d'IPD sont causés par des sérotypes vaccinables. La couverture vaccinale reste très faible. Des adaptations récentes dans les recommandations du Conseil supérieur de la santé simplifient le schéma de vaccination dans le but d'obtenir une plus grande couverture vaccinale et une meilleure protection.

Table des matières

1. Description de la surveillance	4
1.1. Sources de données.....	4
1.1.1. Définition de cas	4
1.1.2. Représentativité des données	5
2. Résultats	6
2.1. Tendances générales	6
2.1.1. Par région	7
2.1.2. Par groupe d'âge	8
2.1.3. Tableau clinique	8
2.1.4. Mortalité	9
2.2. Répartition des sérotypes chez les enfants de moins de 2 ans	10
2.3. Distribution des sérotypes chez les adultes	11
3. Importance pour la santé publique	13
Plus d'informations	14
Références	14
Annexe 1: Vaccins	15

Introduction

Les infections invasives à pneumocoques (IPD) sont causées par *Streptococcus pneumoniae* (pneumocoque), une bactérie qui apparaît fréquemment dans les voies respiratoires supérieures. Lorsque la bactérie pénètre dans des tissus sous-jacents ou dans le système sanguin, cela peut entraîner des infections graves comme une méningite bactérienne, une pneumonie invasive ou une septicémie. Même si tous les groupes d'âge peuvent être touchés, les enfants de moins de deux ans, les personnes de plus de 65 ans et les personnes souffrant d'affections sous-jacentes sont les plus sensibles. Le présent rapport donne un aperçu épidémiologique des infections invasives à pneumocoques en Belgique et soutient l'évaluation et l'optimisation des stratégies nationales de vaccination.

1. Description de la surveillance

1.1. Sources de données

La surveillance des infections invasives à pneumocoques (IPD, 'Invasive Pneumococcal Disease') en Belgique est basée sur des données provenant de différentes sources:

- **Centre national de référence (CNR) pour *Streptococcus pneumoniae* invasif (UZ Leuven):** le CNR est responsable de la surveillance par le sérotypage et le suivi de la résistance aux antibiotiques des isolats de pneumocoques. L'UZ Leuven est CNR depuis 2011.
- **Le réseau des laboratoires vigies (Epilabo):** un réseau de laboratoires qui envoient des données diagnostiques à Sciensano sur une base volontaire. Des cas d'IPD sont enregistrés depuis 1993.
- **Résumé Hospitalier Minimum (RHM):** tous les hôpitaux non psychiatriques de Belgique sont tenus de contribuer à l'enregistrement anonyme de données administratives, médicales et infirmières sur toutes les admissions à l'hôpital. Les maladies sont codées depuis 2016 selon la "Classification internationale des maladies", version 10e (ICD-10). Les données sont disponibles avec un retard de deux ans.
- **PediSurv,** un réseau de surveillance coordonné par Sciensano, assure le suivi des maladies infantiles graves et/ou rares chez les enfants de moins de 15 ans. Les médecins et pédiatres dans l'ensemble de la Belgique et les généralistes à Bruxelles qui participent, rapportent tous les mois les cas éventuels. Les IPD sont suivies depuis 2005.

1.1.1. Définition de cas

Selon le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC), une infection invasive à *Streptococcus pneumoniae* est définie par les critères de laboratoire suivants : isolement et/ou détection de l'acide nucléique et/ou de l'antigène de *S. pneumoniae* dans un site normalement stérile (sang, liquide céphalo-rachidien (LCR) ou autre site profond). Cette définition de cas est utilisée par le CNR, les laboratoires vigies et Pedisurv.

Pour la déduplication des cas, un intervalle de 30 jours interval van 30 dagen est appliqué: plusieurs épisodes chez la même personne avec >30 jours entre sont considérés comme des épisodes infectieux séparés (surinfections possibles). Si un sérotype différent est identifié, ceci est considéré comme un nouvel épisode infectieux, quel que soit l'intervalle de temps entre les deux isolements.

Pour le RHM, nous nous basons sur les hospitalisations avec pour diagnostic principal les codes ICD-10 suivants: A403 (septicémie à pneumocoques), G001 (méningite à pneumocoques) et J13 (pneumonie à pneumocoques). La prudence est de mise pour l'interprétation du code J13, étant donné qu'aucune distinction ne peut être faite dans cette source de données entre pneumonie invasive et non invasive.

1.1.2. Représentativité des données

Aucune de ces sources de données n'est exhaustive et elles ne permettent donc pas d'estimer les nombres absolus de cas d'IPD en Belgique. Les données du CNR offrent l'estimation la plus proche en raison de leur couverture élevée.

Sur la base du remboursement des hémocultures (nombre de remboursements aux laboratoires envoyant des échantillons au **CNR** divisé par le nombre total de remboursements à tous les laboratoires en Belgique), la couverture du CNR est estimée à 98,5% pour 2024, avec une bonne répartition géographique. Pour la période 2011-2024, cette couverture est restée élevée et stable (moyenne de 95% ; intervalle : 91,5-98,5% (Tableau 1)). En 2019 et au cours des trois dernières années, la couverture dépassait 97%. Cette soi-disant augmentation est probablement plutôt la conséquence des effets méthodologiques dus aux fusions des laboratoires qu'à une véritable extension du réseau de surveillance du CNR. La représentativité stable et élevée des données du CNR était le fait que les tendances IPD observées reflètent probablement des changements réels dans le fardeau de la maladie et ne sont pas la conséquence de modifications dans l'intensité de la surveillance.

Tableau 1: calcul de la couverture du CNR pour les pneumocoques invasifs; 2011-2024
(Source : CNR pour *S. pneumoniae*, UZ Leuven; RIZIV/INAMI)

Année	Total des hémocultures remboursées à tous les laboratoires	Hémocultures remboursées aux laboratoires CNR	Couverture du CNR	Nombre de labos CNR/ total de labos avec code INAMI unique
2011	1.243.848	1.187.434	95.46%	88/119
2012	1.311.185	1.256.234	95.81%	90/118
2013	1.339.595	1.231.613	91.94%	84/115
2014	1.365.228	1.294.225	94.80%	83/111
2015	1.462.101	1.353.913	92.60%	81/109
2016	1.599.556	1.527.500	95.50%	84/107
2017	1.679.784	1.545.095	91.98%	78/102
2018	1.807.596	1.655.489	91.59%	77/100
2019	1.870.675	1.820.365	97.31%	77/94
2020	1.871.817	1.740.873	93.00%	74/89
2021	1.934.449	1.853.223	95.80%	73/89
2022	2.083.600	2.038.878	97.85%	73/89
2023	2.161.733	2.128.660	98.47%	74/88
2024	1.856.698	1.828.164	98.46%	72/85

En utilisant la même méthode, la surveillance des laboratoires vigies (**Epilabo**) est estimée à 55% en 2024, avec de grandes différences géographiques : 68% pour la Flandre, 38% pour Bruxelles et 39% pour la Wallonie. Ces données ne sont utilisées que de façon très limitée dans le présent rapport en raison de ce sous-rapportage connu.

Dans le réseau **PediSurv**, des médecins de 22 hôpitaux dans toute la Belgique ont participé aux enregistrements de cas. Selon les estimations, 52% des hospitalisations pédiatriques sont couvertes par les hôpitaux qui participent au réseau. Ces données ne sont pas utilisées pour suivre les tendances mais les enregistrements fournissent des informations cliniques détaillées permettant de compléter, autant que possible, les données du CNR.

Tout comme le CNR, le **Résumé hospitalier minimum** présente peu de variation géographique étant donné que tous les hôpitaux belges sont obligés d'y participer. Il faut toutefois tenir compte de quelques limitations: ces données n'étaient au départ pas collectées à des fins épidémiologiques et le diagnostic et la codification des maladies peuvent varier d'un hôpital à l'autre.

2. Résultats

2.1. Tendances générales

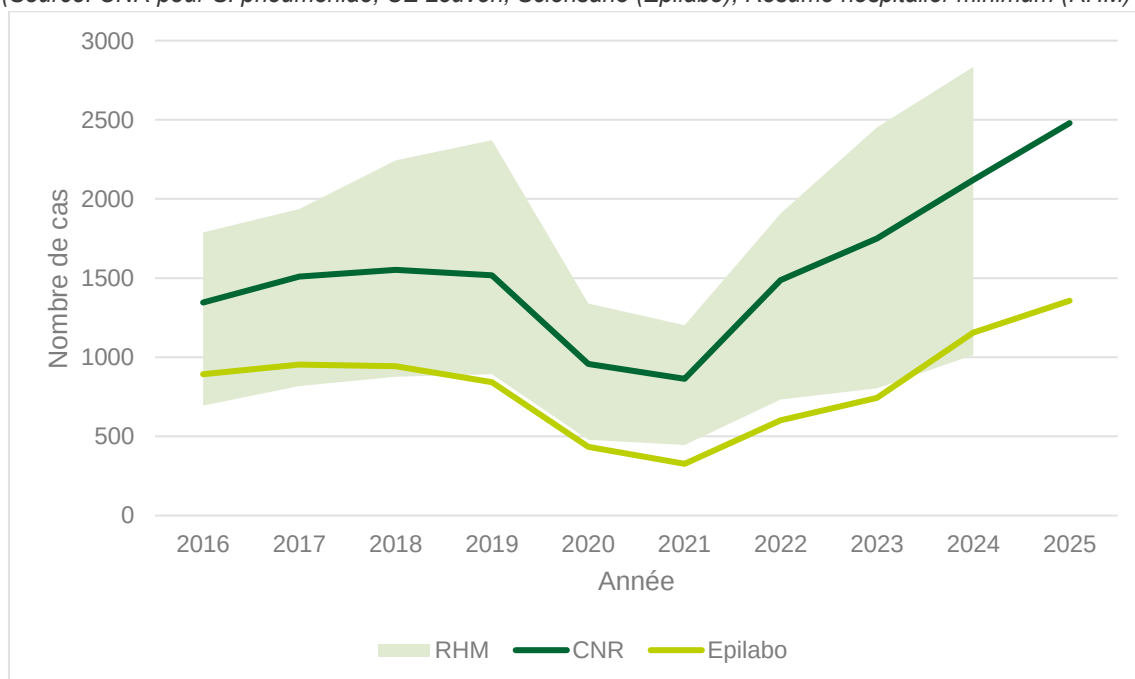
La figure 1 montre l'évolution du nombre de cas d'IPD rapportés et d'hospitalisations liées à des IPD dans les différentes sources de données au cours des années passées.

En 2025, 2479 cas d'IPD ont été rapportés par le CNR. C'est le nombre le plus élevé depuis le début de la surveillance. Au cours de la période précédant le COVID-19 (2016-2019), une moyenne de 1482 souches ont été rapportées par an. Depuis 2022, une augmentation marquée et constante est observée. Le CNR a reçu au cours des dernières années (2022-2024) respectivement 1487, 1750 et 2120 souches *S. pneumoniae* et a rapporté en 2025 une nouvelle augmentation de 17% par rapport à 2024.

Des tendances similaires ont été constatées dans les données des laboratoires vigies. En 2025, 1357 cas ont été rapportés, ce qui représente également une augmentation de 17% par rapport à 2024 (n=1155).

Pour le Résumé hospitalier minimum, les données sont disponibles jusque 2024 inclus et ici aussi, on constate une augmentation du nombre d'hospitalisations. En 2024, 111 hospitalisations pour méningite, 904 pour septicémie et 1819 pour pneumonie (invasive et non invasive) ont été rapportées. Si on considère uniquement les infections invasives (limite inférieure de l'intervalle à la figure 1), il est question de 1015 hospitalisations (+26% par rapport à 2023). Si les pneumonies sont également incluses (limite supérieure de l'intervalle à la figure 1), ce nombre passe à 2834 hospitalisations (+16% par rapport à 2023).

Figure 1: Nombre de cas et d'hospitalisations IPD par an, 2016-2025, Belgique
(Source: CNR pour *S. pneumoniae*, UZ Leuven; Sciensano (Epilabo); Résumé hospitalier minimum (RHM) *)

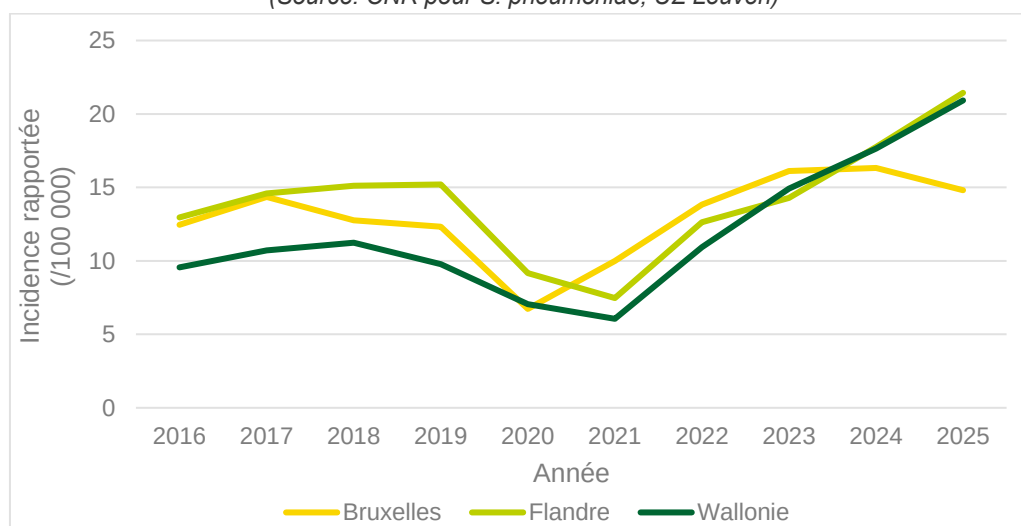


*Les données RHM sont reprises comme un intervalle, en fonction de la définition de cas appliquée: la limite inférieure reprend uniquement les infections certainement invasives (méningite et septicémie), alors que la limite supérieure inclut également les pneumonies, qui ne sont pas toujours confirmées comme invasives.

2.1.1. Par région

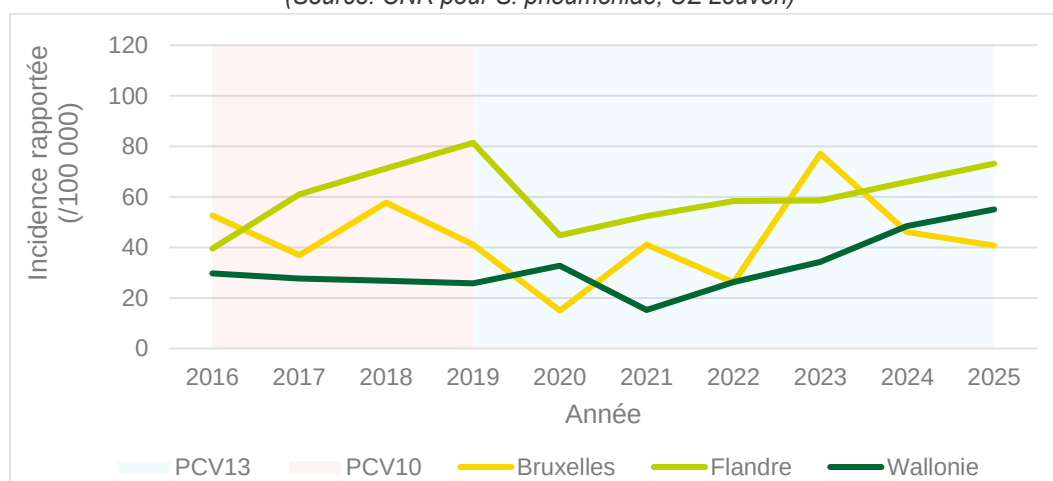
L'incidence rapportée des IPD en Belgique en 2025 était de 21 cas pour 100.000 habitants (18 pour 100.000 en 2024). Tant en Flandre qu'en Wallonie, l'incidence a augmenté par rapport à l'année précédente et a atteint 21 cas pour 100.000 habitants dans les deux régions. En Région de Bruxelles-Capitale en revanche, l'incidence a diminué légèrement pour atteindre 15 cas pour 100.000 habitants (Figure 2).

Figure 2: Incidence rapportée des infections invasives à pneumocoques (cas confirmés/100.000 personnes) par an, par entité fédérée pour tous les âges, 2016-2025, Belgique
(Source: CNR pour *S. pneumoniae*, UZ Leuven)



Spécifiquement pour les enfants de moins de 2 ans, le groupe d'âge qui est la cible des programmes de vaccination, le CNR a enregistré 143 cas (Flandre: 92, Wallonie: 37, Bruxelles: 11, inconnu: 3), ce qui correspond à une incidence totale de 65 cas pour 100.000 enfants (59 pour 100.000 en 2024). Dans ce groupe d'âge également, le même schéma a été observé, avec une augmentation en Flandre et en Wallonie (respectivement 73 et 55 pour 100.000) et une diminution en Région de Bruxelles-Capitale (41 pour 100.000) (Figure 3).

Figure 3: Incidence rapportée des infections invasives à pneumocoques (cas confirmés/100.000 personnes) par an, par entité fédérée pour les enfants de moins de 2 ans, 2016-2025, Belgique
(Source: CNR pour *S. pneumoniae*, UZ Leuven)



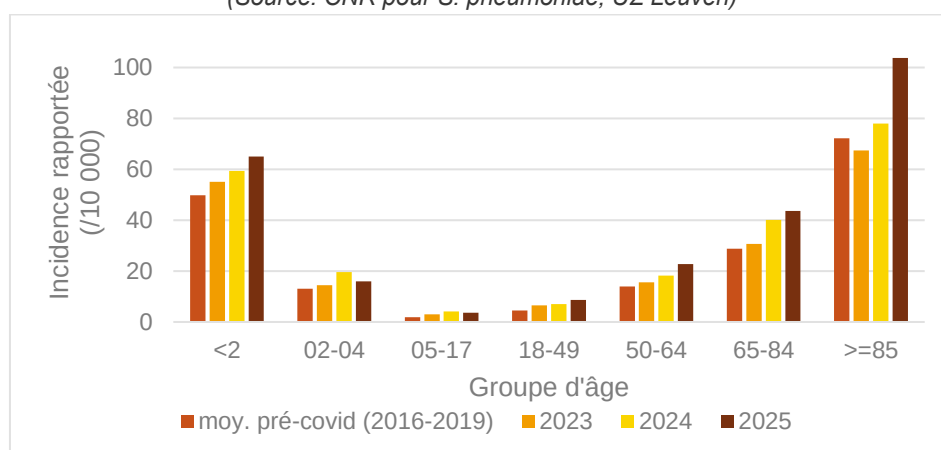
Note: les chiffres d'incidence pour Bruxelles sont plus sensibles à des fluctuations, en raison des nombres absolus moins élevés.

2.1.2. Par groupe d'âge

L'augmentation des cas d'IPD s'est produite dans différents groupes d'âge. Chez les enfants de moins de 2 ans, le nombre de cas est passé de 134 en 2024 à 143 en 2025 (+7%), et dans tous les groupes d'âge adulte également, des augmentations évidentes ont été constatées. Tant pour le groupe des 18-49 ans que pour celui des 50-64 ans, une croissance de 24% du nombre de cas a été constatée par rapport à l'année précédente, avec respectivement 415 et 529 cas. L'augmentation relative chez les personnes de 65-84 ans était plus limitée (+11%), bien que ce groupe reste celui connaissant le nombre absolu d'infections le plus élevé (n=895). La croissance la plus spectaculaire a été observée chez les plus de 85 ans, +36% (n=370).

Même si le nombre absolu de cas le plus élevé est observé chez les personnes de 65-84 ans, les chiffres d'incidence montrent que le risque de contracter une IPD est le plus grand chez les enfants de moins de 2 ans et chez les adultes plus âgés, en particulier chez les personnes de 85 ans et plus (Figure 4).

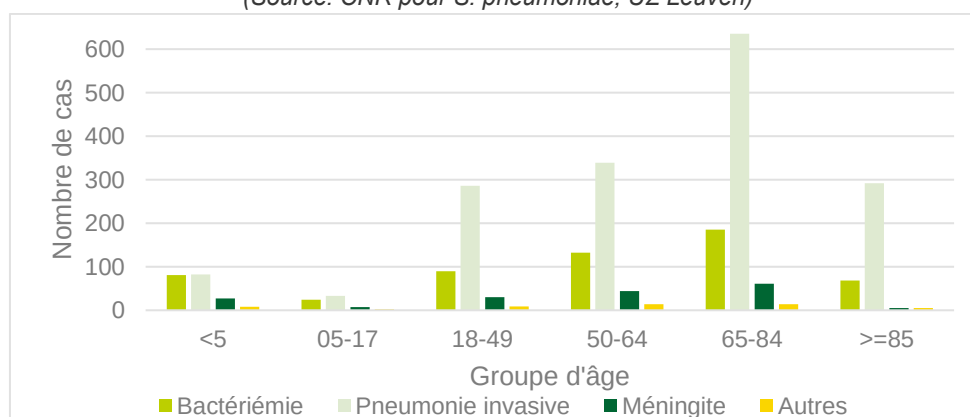
Figure 4: Incidence IPD rapportée (/100.000 personnes) par an et par groupe d'âge, 2016-2025, Belgique
(Source: CNR pour *S. pneumoniae*, UZ Leuven)



2.1.3. Tableau clinique

Le tableau clinique des infections invasives à pneumocoques varie avec l'âge (Figure 5). Chez les jeunes enfants, la bactériémie et la pneumonie invasive sont les tableaux cliniques les plus fréquents (chacune 41% des cas). Chez les adultes et les personnes âgées, la majorité des cas concerne une pneumonie invasive (70%) ou une bactériémie (20%). Le forte augmentation des cas en 2025 s'exprime principalement par une augmentation du nombre de pneumonies dans les groupes d'âge adultes.

Figure 5: Cas rapportés d'infections invasives à pneumocoques par tableau clinique, par groupe d'âge, 2025, Belgique
(Source: CNR pour *S. pneumoniae*, UZ Leuven)



La méningite est un tableau clinique plus rare, 174 (7%) de tous les cas d'IPD se présentent comme une méningite. C'est une augmentation tant en nombre absolu que proportionnellement au nombre total d'IPD (130 cas (6.1%) en 2023). Proportionnellement, la méningite se produit plus souvent chez les jeunes enfants, en particulier chez les enfants de <1 an où 21% (n=19) de tous les cas d'IPD se présentent comme une méningite.

Dans le groupe des moins de 2 ans, 23 cas de méningite ont été rapportés, une légère augmentation par rapport aux années précédentes (chaque fois n=19). La proportion de méningites parmi les cas d'IPD de ce groupe d'âge (16%) est toutefois restée stable, avec des valeurs situées entre 14% et 18% les années passées. Parmi ces cas, 9 ont été causés par des sérotypes repris dans le PCV20 (dont 1 aussi dans le PCV13), les 14 autres par des types non vaccinables. Les sérotypes les plus fréquents qui causent une méningite chez les enfants sont le 23B (n=5) et le 10A (n=3). PediSurv également a rapporté 10 cas de méningite chez des enfants de moins de 2 ans, qui étaient déjà tous repris dans la base de données du CNR.

L'augmentation des cas de méningite est également observée dans tous les groupes d'âge adultes, avec 140 cas chez les personnes de 18 ans et plus (contre 100 en 2024). Chez les adultes, la distribution des sérotypes de la méningite est différente : les sérotypes les plus fréquents sont 12F, 8 et 3, tous des sérotypes PCV20.

2.1.4. Mortalité

Dans 75% des cas rapportés par le CNR, des informations étaient disponibles sur le décès du patient dans les 3 jours suivant un diagnostic d'IPD. Il s'agit d'une surveillance basée sur les laboratoires, où les résultats des patients ne sont pas toujours connus des laboratoires au moment de la déclaration, ce qui conduit à des données incomplètes. De plus, seuls les décès survenus dans les trois jours sont inclus, et la date à laquelle la souche est envoyée au CNR peut en partie déterminer si un décès sera ou non enregistré.

Sur cette base, au moins 145 décès ont été rapportés dans les trois jours en 2025. Trois quarts de ces décès (105/145) concernaient des personnes de plus de 65 ans. Chez les enfants de moins de 2 ans, au moins 7 décès ont été signalés en 2025. Au cours des années précédentes, toutes les sources de données (RHM et CNR combinés à PediSurv) ont toujours rapporté moins de 5 décès dans ce groupe d'âge. Quatre des décès survenus en 2025 étaient la conséquence d'une infection par un sérotype repris dans le PCV20 (Tableau 2).

*Tableau 2: aperçu du sérotype et du statut vaccinal pour le décès des enfants (<2 ans), 2025, Belgique
(Source: CNR pour S. pneumoniae, UZ Leuven; Pedisurv, Sciensano)*

Tableau clinique	Sérotype	Type de vaccin	Statut vaccinal
Bactériémie	12F	PCV20	Vacciné (PCV13)
Méningite	14	PCV7	Non vacciné
Méningite	22F	PCV15/PCV20	Vacciné (PCV13)
Méningite	22F	PCV15/PCV20	Inconnu
Méningite	7B	Non vaccinable	Vacciné (PCV13)
Méningite	16F	Non vaccinable	Vacciné (PCV13)
Méningite	16F	Non vaccinable	Inconnu

En complément, les données hospitalières pour 2024 donnent une idée des décès survenus chez les patients hospitalisés. Au total, 116 décès par suite d'une septicémie ont été rapportés, ce qui correspond à un case fatality rate (CFR) de 13%. Pour la méningite, 11 décès ont été enregistrés (CFR 11%), et pour la pneumonie, 100 décès (CFR 5%). Cette source de données aussi montre que la plupart des décès se produisent à un âge plus élevé: 45% des décès concernaient des personnes de 65-84 ans, et 36% concernaient des personnes de plus de 85 ans.

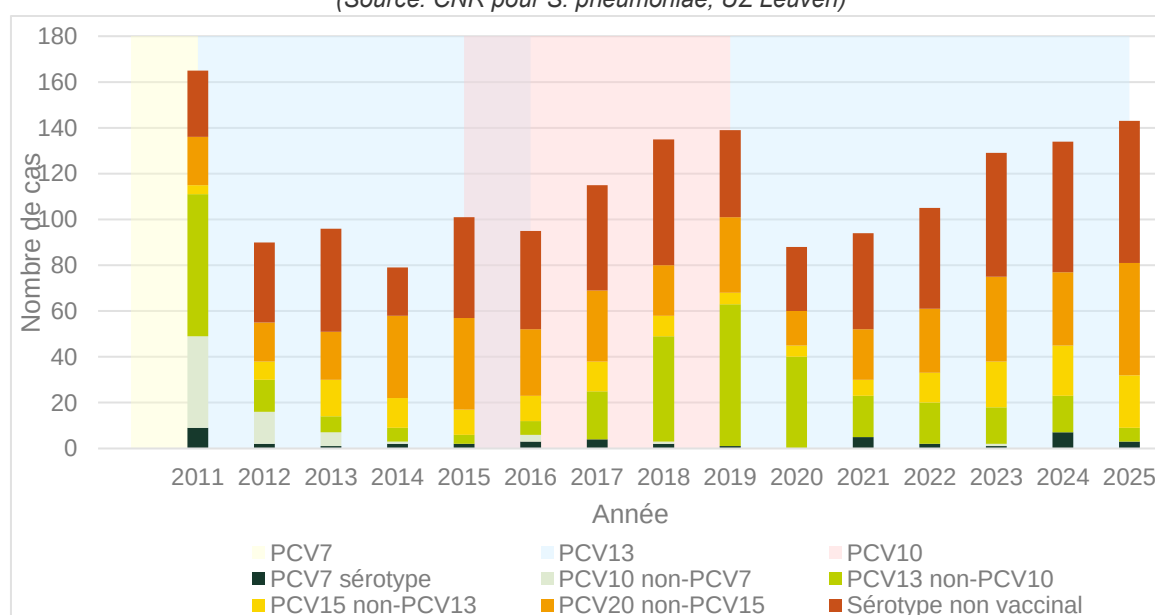
2.2. Répartition des sérotypes chez les enfants de moins de 2 ans

Au total, plus de 100 sérotypes de pneumocoques ont été décrits, mais seuls certains d'entre eux provoquent des maladies pneumococciques invasives. Les vaccins antipneumococciques conjugués (PCV) actuellement sur le marché offrent une protection contre un certain nombre de sérotypes. L'utilisation des différents vaccins antipneumococciques au cours des ans a donc eu un impact sur la distribution des sérotypes. Un aperçu des sérotypes par vaccin est repris à l'annexe 1.

Lors de la période PCV10, une augmentation des sérotypes couverts exclusivement par PCV13, principalement 19A, a été observée chez les enfants de moins de 2 ans (Figure 6). Suite à cela, PCV13 a de nouveau été introduit dans le programme de vaccination, ce qui a entraîné une forte baisse de ces sérotypes: de 45% en 2019 à 12% en 2024, et ensuite à 4% en 2025 (sérotypes 19A et 3, chacun 3 cas). En 2024, une légère augmentation des sérotypes PCV7 a été observée mais en 2025, ce nombre a de nouveau diminué pour atteindre seulement 3 cas (sérotypes 14 (2) et 19F). Au total, 6% des cas ont été causés par des sérotypes PCV13 vaccinables.

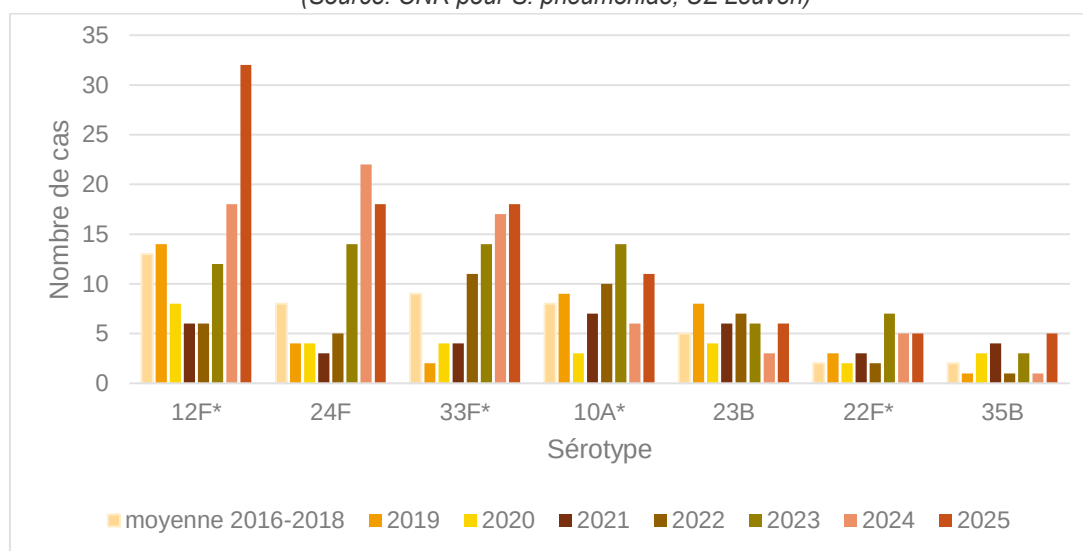
La baisse des sérotypes vaccinaux depuis 2019 va de pair avec une augmentation des infections causées par des sérotypes non vaccinables, un phénomène appelé remplacement des sérotypes. C'est ainsi que ces dernières années, la proportion des types PCV15 et PCV20, non inclus dans PCV13, augmente. En 2025, 50% (n=72) des infections IPD chez les enfants de moins de 2 ans étaient causées par des sérotypes repris uniquement dans ces vaccins à valence plus élevée, une augmentation par rapport aux années précédentes (41% en 2024).

Figure 6: Nombre de cas rapportés pour les enfants de <2 ans selon les sérotypes vaccinaux, 2011-2025, Belgique
(Source: CNR pour *S. pneumoniae*, UZ Leuven)



La Figure 7 montre les sérotypes les plus fréquents chez les enfants de moins de 2 ans et leur évolution au cours des dernières années, par ordre de fréquence en 2025. Le sérotype le plus fréquent est 12F, responsable de 22% (n=32) des cas dans ce groupe d'âge, suivi de 24F et 33F (chacun 13%) et 10A (8%). Les sérotypes 23B, 22F et 35B complètent la liste des types les plus fréquents. Les autres sérotypes n'intervenaient chacun que dans moins de cinq cas et ne sont pas repris. Aucun des sérotypes indiqués dans la figure 7 n'est repris dans l'actuel vaccin PCV13. Les sérotypes marqués d'un * ont été repris dans le PCV20 à valence plus élevée.

Figure 7: Nombre de cas d'IPD par sérotype chez les enfants de moins de 2 ans pour les sérotypes les plus fréquemment rapportés, 2016-2025, Belgique
(Source: CNR pour *S. pneumoniae*, UZ Leuven)

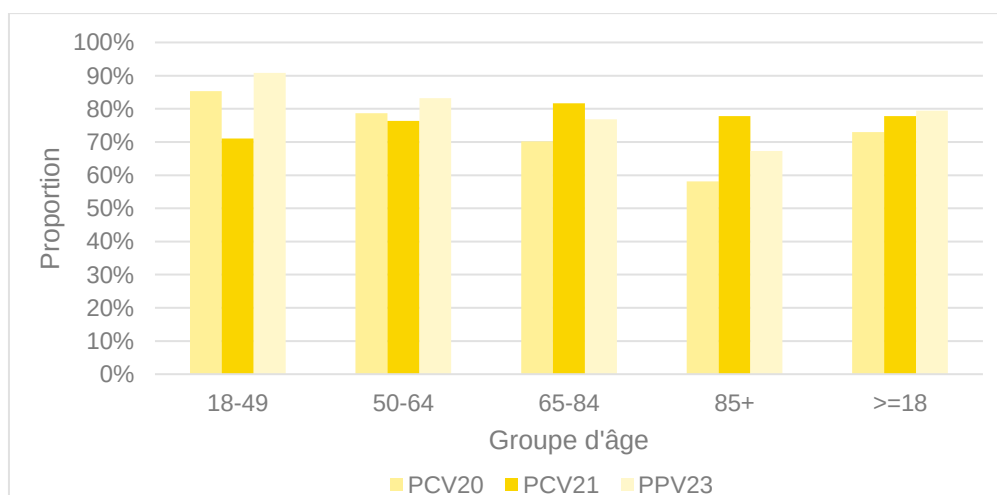


2.3. Distribution des sérotypes chez les adultes

Tout comme c'est le cas pour les jeunes enfants, la distribution des sérotypes chez les adultes est potentiellement influencée par la vaccination, d'une part par les effets indirects de la vaccination infantile et d'autre part, en raison des recommandations vaccinales pour les adultes. Contrairement aux enfants, il n'existe toutefois pas de programme de vaccination systématique pour les adultes, ce qui fait que la vaccination est pratiquée d'une manière moins uniforme.

Chez les adultes, on a utilisé au cours de la dernière décennie le vaccin polysaccharidique PPV23, seul ou en association avec des vaccins conjugués à valence moins élevée, et à partir de 2022 également le PCV20. Récemment, le PCV21 a également été approuvé pour les adultes. La Figure 8 montre la proportion de cas d'IPD chez les adultes, causés par des sérotypes inclus dans ces vaccins de valence plus élevée.

Figure 8: Proportion de cas d'IPD par type de vaccin chez les adultes, 2025, Belgique
(Source: CNR pour *S. pneumoniae*, UZ Leuven)

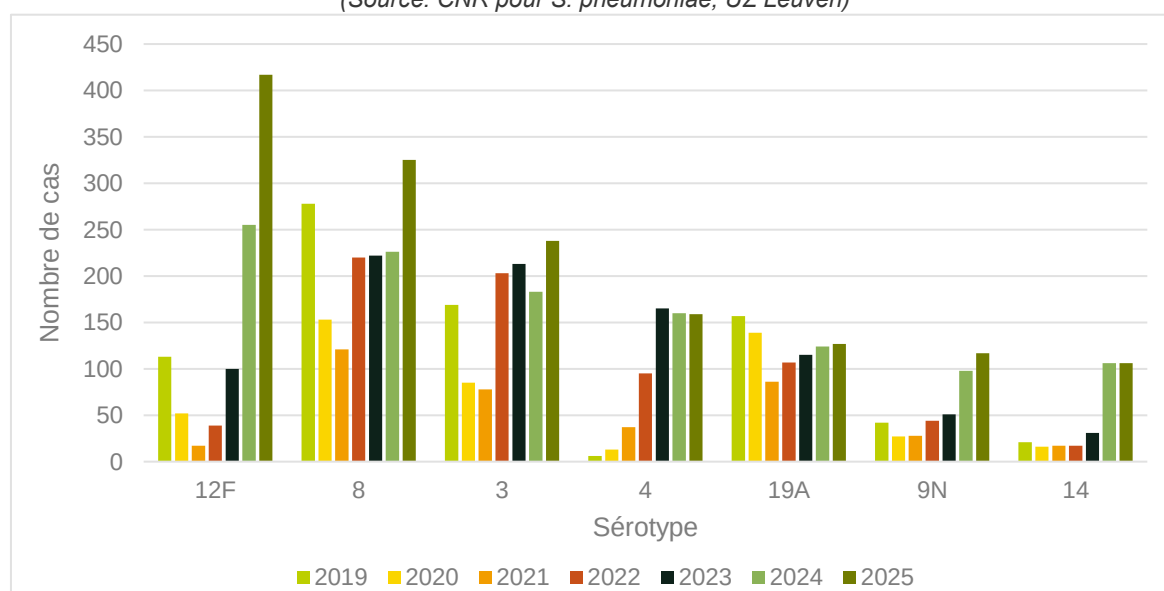


En 2025, les vingt sérotypes inclus dans le PCV20 étaient responsables de 73% des cas d'IPD chez les adultes (Figure 8), un pourcentage comparable à celui des années précédentes (2018-2024), au cours desquelles la proportion a varié entre 66% et 75%, sans tendance claire. La couverture sérotypique théorique de ce vaccin est toutefois différente selon le groupe d'âge et diminue à mesure que les patients vieillissent : 85% des infections pour le groupe 18-49 ans, 79% pour le groupe 50-64 ans, 70% pour le groupe 65-84 ans et 58% chez les plus de 85 ans ont été causées par des sérotypes PCV20.

Pour les sérotypes PCV21, un schéma similaire a été observé. En 2025, ils étaient responsables de 78% des cas d'IPD chez les adultes (intervalle dernières années: 76-83%). La proportion la plus élevée a été observée dans le groupe des 65-84 ans (81%), alors que la proportion la moins élevée l'était dans le groupe des 18-49 ans (71%).

La distribution des sérotypes chez les adultes est différente de celle des jeunes enfants. En 2025, le sérotype 12F, était le plus fréquent, tout comme chez les enfants, et responsable de 19% des cas d'IPD chez les adultes (n=417). Ce sérotype a connu une augmentation très marquée ces dernières années, passant de 3% en 2022 à 7% en 2023 et à 14% en 2024. Contrairement aux enfants, le sérotype 8 (15%) et le sérotype 3 (11%) font partie des types les plus fréquents. Le sérotype 4, qui représentait encore 11% des cas en 2023, a de nouveau diminué jusque 7% en 2025. Pour le sérotype 19A, une faible augmentation en nombres absolus a été observée mais une baisse en proportion (6% en 2025), ce qui indique une augmentation relativement moins importante en comparaison des autres sérotypes. En outre, on observe également depuis 2024 une augmentation des sérotypes 9N et 14, qui étaient responsables chacun d'environ 5% des cas en 2025. Les autres sérotypes sont intervenus chacun dans moins de 5% des cas et ils ne sont pas repris séparément ici. Tous ces types fréquents sont couverts par PCV20 et/ou PCV21.

Figure 9: Nombre de cas d'IPD par sérotype chez les adultes (≥ 18 ans) pour les sérotypes les plus fréquemment rapportés, 2016-2025, Belgique
(Source: CNR pour *S. pneumoniae*, UZ Leuven)



Si on limite l'analyse ci-dessus aux personnes de 65 ans et plus, le schéma général est en grande partie maintenu, avec les trois mêmes sérotypes dominants (12F, 8 et 3). Les sérotypes suivants (19A, 9N, 14) présentent également un classement similaire, à l'exception du type 4 qui descend à la septième place. La hausse récente du sérotype 4 en 2023 est principalement due aux adultes plus jeunes (2), ce qui explique le pourcentage plus faible dans le groupe d'âge plus âgé.

3. Importance pour la santé publique

En 2025, la Belgique a connu une nouvelle fois une forte augmentation des cas d'IPD, la plus prononcée chez les adultes plus âgés. La cause de cette augmentation reste obscure. Étant donné la stabilité de la surveillance du CNR, il semblerait qu'il s'agisse bien d'une augmentation réelle du fardeau de la maladie. Cette recrudescence des maladies pneumococciques invasives est inquiétante, étant donné que *S. pneumoniae* est la principale cause de mortalité par méningite et infections des voies respiratoires inférieures dans le monde, comme il ressort d'estimations récentes sur le *burden of disease* (3,4). Le fardeau de la maladie est donc considérable mais il peut en grande partie être évité par la vaccination. La priorité des programmes de vaccination est la prévention des infections invasives à pneumocoques chez les jeunes enfants. La vaccination offre toutefois des avantages multiples, dont une protection contre les invasions non invasives (comme l'otite moyenne aiguë), une réduction de la circulation des pneumocoques résistants aux antibiotiques et une immunité muqueuse, ce qui permet de protéger indirectement même les populations non vaccinées.

Le programme de vaccination chez les enfants, avec le PCV13 à 8 et 12 semaines et à 12 mois, connaît une couverture vaccinale élevée et stable de 94% (5) et a eu pour résultat une forte diminution des sérotypes vaccinaux: en 2025, seulement 6% des cas d'IPD chez les enfants de moins de 2 ans étaient encore causés par des sérotypes PCV13. Parallèlement, un changement de sérotype est observé, avec un pourcentage croissant de sérotypes PCV20 et une forte augmentation du sérotype 12F. De même, le nombre total d'infections augmente à nouveau, également chez les jeunes enfants. Ces évolutions ont entraîné une adaptation des recommandations vaccinales du CSS: depuis 2025, le PCV20 est recommandé dans un schéma 3+1 (6). Actuellement, le PCV13 reste le vaccin proposé gratuitement dans les programmes de vaccination des communautés. Jusqu'à 57% des infections et 4 décès dans ce groupe d'âge ont cependant été causés par des sérotypes PCV20 en 2025, ce qui souligne la pertinence de cette recommandation.

Le plus grand nombre d'infections, d'hospitalisations et de décès est constaté chez les adultes et les personnes âgées, avec une incidence en hausse, en particulier chez les plus de 85 ans. Malgré les recommandations actuelles, la couverture vaccinale reste faible (16% chez les plus de 65 ans et <10% dans les groupes à risque de 50-64 ans (7)), tandis qu'une part importante des cas (>70%) est causée par des types vaccinables et est théoriquement évitable dans le cas d'une couverture vaccinale plus élevée. La faible couverture vaccinale est multifactorielle et est liée à des obstacles financiers dus à des critères de remboursement limités et à un manque de recommandation et de sensibilisation systématiques.

En 2025, le CSS a revu ses recommandations, avec l'introduction d'un schéma simplifié basé sur une seule dose d'un vaccin conjugué à valence plus élevée (PCV20 ou PCV21), adapté à l'âge et au profil de risque. Cette simplification a pour but de faciliter l'implémentation et de renforcer la couverture vaccinale. Le nouveau schéma se présente comme suit: PCV20 pour les adultes de 18-49 ans présentant des facteurs de risque; PCV20 ou PCV21 pour les adultes de 50-64 présentant des facteurs de risque et toutes les personnes de plus de 65 ans (sans limite d'âge supérieure), le PCV21 étant la préférence pour les plus de 85 ans (8).

Une approche plus structurée est toutefois nécessaire, par exemple via un programme de vaccination organisé pour les adultes et un système d'invitation proactif, à l'exemple des Pays-Bas où la couverture vaccinale est élevée et où une augmentation prononcée similaire reste absente (9,10), et où l'extension des critères de remboursement est en phase avec les recommandations. De plus, l'absence de données vaccinales de qualité chez les adultes constitue une limitation importante, ce qui entrave l'évaluation de l'effectivité vaccinale. Un enregistrement renforcé et un couplage de données des registres de vaccination avec les données de surveillance sont essentiels pour y parvenir.

L'épidémiologie en changement, combinée à l'introduction de nouveaux vaccins à valence plus élevée, exige une révision régulière des recommandations vaccinales. Continuer à suivre l'incidence de l'IPD, la mortalité, la distribution des sérotypes et le statut vaccinal, reste essentiel pour informer les politiques et pour orienter et évaluer la politique vaccinale basée sur des preuves.

Plus d'informations

- Rapports épidémiologiques années précédentes: [Sciensano](#)
- [Rapport annuel 2025](#) du CNR pour l'IPD, UZ Leuven
- Informations générales sur les infections invasives à pneumocoques: [ECDC](#)
- Information sur la vaccination: [Conseil supérieur de la santé](#)
- [Allesovervaccineren.be](#) (NL)
- [Vaccination-info.be](#) (FR)

Références

- (1) Berger N, Muyltermans G, Dupont Y, et al. Assessing the sensitivity and representativeness of the Belgian Sentinel Network of Laboratories using test reimbursement data. *Arch Public Health*. 2016;74:29. doi:10.1186/s13690-016-0145-9
- (2) Cuypers L, Sanchez GJ, Herrera Avila JP, et al. Rapid increase in serotype 4 invasive pneumococcal disease among vulnerable young male adults in Belgium (2020-2024). *Int J Infect Dis*. 2026;163:108216. doi:10.1016/j.ijid.2025.108216
- (3) Sirota S, Bender R, Dominguez R, et al. Global, regional, and national burden of Méningite, its risk factors, and aetiologies, 1990–2023: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2023. *Lancet Neurol*. 2026;25:451-468.
- (4) Sirota S, Bender R, Dominguez R, et al. Global burden of lower respiratory infections and aetiologies, 1990–2023: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2023. *Lancet Infect Dis*. 2025;26:343-361.
- (5) WHO & Unicef. WHO/UNICEF Estimates of National Immunization Coverage (WUENIC). 2024.
- (6) Hoge Gezondheidsraad. Advies 9836: pneumokokkenvaccinatie voor kinderen (herziening 2025). Gepubliceerd april 2025. Geraadpleegd [datum]. Beschikbaar via: [Advies 9836 – pneumokokkenvaccinatie voor kinderen](#)
- (7) Hermans L, Drieskens S., Berete F, Boone C, Braekman E, Charafeddine R, Demarest S, Gisle L, Janssens M, Van der Heyden J and Verhaegen K. Health Interview Survey, Belgium, 2001 – 2004 – 2008 – 2013 – 2018 – 2023-2024: Health Interview Survey Interactive Analysis. Brussels: Sciensano.
- (8) Hoge Gezondheidsraad. Advies 9842: vaccinatie tegen pneumokokken bij volwassenen (herziening 2025). Gepubliceerd 2025. Geraadpleegd [datum]. Beschikbaar via: [Advies 9842 – pneumokokkenvaccinatie volwassenen](#)
- (9) C. Laarman, M. Heins, F. Stelma, M. Hooiveld. Monitor Vaccinatiegraad Nationaal Programma Pneumokokkenvaccinatie Volwassenen (NPPV) 2024. 2025. Beschikbaar op: <https://www.nivel.nl/sites/default/files/bestanden/13154.pdf>
- (10) van Roon AM, Lanooij SJ, de Melker HE. The National Immunisation Programme in the Netherlands: surveillance and developments in 2023-2024. Bilthoven; 2024.

Ce projet est soutenu financièrement par:



Volksgezondheid
Veiligheid van de Voedselketen
Leefmilieu



Wallonie
familles santé handicap
AVIQ



Annexe 1: Vaccins

En Belgique, la vaccination contre les infections pneumococciques chez les nourrissons a été recommandée par le Conseil supérieur de la santé (CSS). Cette recommandation peut changer en fonction des vaccins disponibles et de l'épidémiologie belge. Les programmes de vaccination gouvernementaux ont utilisé différents vaccins pneumococciques conjugués (PCV) au cours des ans. Le Tableau 1 montre la composition des vaccins utilisés dans le programme vaccinal de base pour les enfants. Le tableau 2 donne un aperçu des vaccins à valence élevée (PCV15 et PCV20) et le tableau 3 donne un aperçu des vaccins destinés à la vaccination des adultes.

Tableau 1 : Composition des vaccins pneumococciques utilisés dans les programmes de vaccination des enfants en Belgique

Vaccins	Sérotypes	Programme de vaccination du gouvernement
PCV7 (Prevenar®)	4, 6B, 9V, 14, 18C, 19F, 23F	Flandre: Janvier 2007 - Juin 2011 Wallonie: Janvier 2007 - Septembre 2011
PCV13 (Prevenar 13®)	PCV7 + 1, 3, 5, 6A, 7F, 19A	Flandre: juillet 2011 - juin 2015 Wallonie: octobre 2011 - avril 2016
PCV10 (Synflorix®)	PCV7 + 1, 5, 7F	Flandre: juillet 2015 - juin 2019 Wallonie: mai 2016 - août 2019
PCV13 (Prevenar 13®)	PCV7 + 1, 3, 5, 6A, 7F, 19A	Flandre: depuis juillet 2019 Wallonie: depuis septembre 2019

Tableau 2 : Composition d'autres vaccins antipneumococciques disponibles et recommandés pour les enfants en Belgique

Vaccins	Sérotypes	Remarque
PCV15 (Vaxneuvance®)	PCV13 + 22F, 33F	
PCV20 (Apexxnar®)	PCV13 + 22F, 33F, 8, 10A, 11A, 12F, 15B	Depuis avril 2025, le CSS recommande le PCV20 dans un schéma 3+1 pour tous les enfants.

Tableau 3: Composition des vaccins antipneumococciques pour la vaccination des adultes en Belgique

Vaccins	Sérotypes	Remarque
PCV20 (Apexxnar®)	1, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7F, 8, 9V, 10A, 11A, 12F, 14, 15B, 18C, 19A, 19F, 22F, 23F, 33F	Le CSS recommande le PCV20 pour les adultes de 18-49 ans présentant des facteurs de risque; le PCV20 ou le PCV21 pour les adultes de 50-64 présentant des facteurs de risque et pour toutes les personnes de 65-84 ans; pour les personnes de 85 ans et plus, le PCV21 est le premier choix.
PCV21 (Capvaxive®)	3, 6A, 7F, 8, 9N, 10A, 11A, 12F, 15A, 15B, 16F, 17F, 19A, 20A, 22F, 23A, 23B, 24F, 31, 33F, 35B	
PPV23 (Pneumovax 23®)	1, 2, 3, 4, 5, 6B, 7F, 8, 9N, 9V, 10A, 11A, 12F, 14, 15B, 17F, 18C, 19A, 19F, 20, 22F, 23F, 33F	N'est plus recommandé pour la vaccination de routine des adultes.

CONTACT

Surveillance épidémiologique des maladies infectieuses évitables par la vaccination :
vpd@sciensano.be.

Personne de contact épidémiologie des infections invasives à pneumocoques:
cato.dambre@sciensano.be

A PROPOS DE SCIENSANO

Sciensano is een openbaar en onafhankelijk wetenschappelijk instituut, dat zich inzet voor de gezondheid van mens en dier en hun omgeving.

We doen wetenschappelijk onderzoek en surveillance, en ondersteunen de overheid en verschillende agentschappen en organisaties met expertise, adviezen en diensten op vlak van gezondheid.

Sciensano hecht veel belang aan het One Health-principe, dat benadrukt dat de gezondheid van mens, dier en hun omgeving onderling verbonden zijn. Daarom is ons onderzoek interdisciplinair en integreert het verschillende invalshoeken.

Met meer dan duizend medewerkers en 120 jaar aan wetenschappelijke expertise, is Sciensano een gerenommeerd wetenschapsinstituut, dat deel uitmaakt van verschillende internationale wetenschappelijke netwerken.

MEER INFO

Sciensano.be – info@sciensano.be

Juliette Wytsmanstraat 14 • Brussel • België • T + 32 2 642 51 11